

DETECCIÓN PRECOZ DE FENILQUETONURIA E HIPOTIROIDISMO CONGENITO

A todos los recién nacidos en el Hospital Clínico, Clínica UC y Clínica San Carlos, se les realiza el examen para la detección precoz de Fenilketonuria e Hipotiroidismo Congénito respondiendo al programa nacional que existe en Chile.

¿Qué es la Fenilketonuria (PKU)?

La fenilketonuria es un defecto hereditario del metabolismo de un aminoácido denominado fenilalanina. Los niños que nacen con este defecto no pueden utilizar este aminoácido, presente en todos los alimentos y como consecuencia, se acumula en la sangre provocando un daño progresivo al cerebro, produciendo retraso mental severo. Si este defecto es detectado antes del primer mes de vida y se proporciona el tratamiento específico, el niño no presentará problemas posteriores.

¿Qué es el Hipotiroidismo Congénito (HC)?

Existen casos de recién nacidos que no producen la hormona tiroidea, lo que afectará su crecimiento, siendo más lento de lo normal y causándole retraso mental profundo. Si el hipotiroidismo congénito es diagnosticado precozmente y antes del primer mes de vida se le administra la hormona tiroidea de reemplazo al niño(a), el problema se soluciona y tendrá un crecimiento y desarrollo normal.

¿Por qué debe realizarse este examen?

Si bien sólo un pequeño porcentaje de recién nacidos puede presentar Fenilketonuria y/o Hipotiroidismo Congénito, la única manera de identificar a los niños que tienen posibilidades de desarrollar una de estas enfermedades, es hacerles un examen de sangre al momento de nacer.

Los programas de pesquisa neonatal tienen como objetivo detectar precozmente enfermedades en el recién nacido, que pueden resultar en mortalidad en el período neonatal precoz o en discapacidades que perduran toda la vida. Cuando éstas son detectadas y tratadas oportunamente los niños desarrollan normalmente sus potencialidades y capacidades.

¿Cuándo y cómo se toma el examen?

La muestra de sangre se puede tomar desde las 40 horas de vida cumplidas a todos los recién nacidos de término y con al menos 24 horas desde el inicio de la alimentación láctea. En el caso de los niños prematuros de 36 semanas de gestación se debe tomar la muestra el 7mo día de vida; a los prematuros de 35 semanas o menos, se debe tomar la muestra de sangre al 7mo día de vida y repetir el examen a los 15 días. En ambos casos con al menos 24 horas desde el inicio de la alimentación láctea.

DETECCIÓN PRECOZ DE FENILQUETONURIA E HIPOTIROIDISMO CONGENITO



La muestra de sangre es obtenida a través de la punción del dorso de la mano del niño, dejando caer algunas gotas de sangre sobre una tarjeta de papel filtro.

¿Cómo conocer los resultados?

El resultado será conocido a los 10 días hábiles de tomada la muestra. El resultado debe ser entregado a su pediatra en el control más cercano. El resultado debe ser retirado en cualquier Toma de Muestra de la Red de Salud UC CHRISTUS, presentando el carnet de alta del recién nacido.

El Laboratorio tiene definido un procedimiento de seguimiento de resultados que requieren confirmación en nueva muestra, por lo que es posible se contacte a los padres cuando se requiera. Los resultados que se encuentren sobre el límite definido serán notificados oportunamente.

Validada por Unidad Técnica de Educación – 2015.